

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE DISCAPACIDAD DE LA OMS (WHODAS 2.0)

Eje IV: Discapacidad y Funcionamiento • Marco Conceptual de la CIF / OMS

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario para la Evaluación de Discapacidad de la OMS 2.0 (WHODAS 2.0).
Nombre Original	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (Üstün et al., 2010).
Autores Originales	Organización Mundial de la Salud (Grupo de Clasificación, Terminología y Estándares).
Adaptación Hispana	José Luis Vázquez-Barquero et al. (2006); CIBERSAM / Ministerio de Sanidad de España.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Discapacidad Funcional. Nivel de limitación en la actividad y restricción en la participación.
Tipo de Instrumento	Cuestionario estandarizado multidimensional (forma completa 36 ítems o breve 12 ítems).
Formato de Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 = Ninguna dificultad a 5 = Extrema o no puede hacerlo).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años); autoadministrado, heteroaplicado por clínico o por informante clave.
Tiempo de Administración	15 a 20 minutos (versión 36 ítems) o 5 minutos (versión 12 ítems).
Régimen de Licencia	Distribución gratuita por la OMS para investigación y práctica clínica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MARCO DE LA CIF DE LA OMS

El **WHODAS 2.0** fue desarrollado por la OMS para operacionalizar los postulados de la **Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF / ICF)**:

- Modelo Biopsicosocial Universal:** La discapacidad no es un atributo estático inherente a una enfermedad o diagnóstico médico, sino el resultado interactivo entre un problema de salud y los factores contextuales (ambientales y personales) del individuo.
- Transversalidad Transdiagnóstica:** Evalúa el impacto funcional derivado de cualquier condición física, mental, neurológica o sensorial, permitiendo comparar objetivamente el nivel de incapacidad entre diferentes patologías.
- Marco Temporal de 30 Días:** Explora el grado de dificultad real experimentado durante el último mes, ponderando la energía y el esfuerzo suplementario que el sujeto debe invertir para desempeñar sus roles habituales.

3. DOMINIOS EVALUADOS SEGÚN LA CIF (6 ÁREAS VITALES / 36 ÍTEMS)

Dominio Funcional CIF	Nº Ítems	Contenido y Actividades Evaluadas en el WHODAS 2.0
1. Comprensión y Comunicación	6 ítems	Concentrarse, recordar, resolver problemas, aprender tareas, comprender y hablar.
2. Capacidad de Movilidad	5 ítems	Estar de pie, levantarse de una silla, moverse dentro del hogar, salir y caminar distancias.
3. Cuidado Personal	4 ítems	Lavarse el cuerpo entero, vestirse, comer sin ayuda y permanecer solo sin riesgo.
4. Relación con los Demás	5 ítems	Relacionarse con desconocidos, mantener amistades, convivencia con allegados y vida sexual.
5. Actividades Cotidianas	8 ítems	Subdominio doméstico (4 ítems: limpieza, cocina) y ocupacional (4 ítems: trabajo/ estudio).
6. Participación Social	8 ítems	Participar en comunidad, barreras del entorno, dignidad, impacto familiar y ocio.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

El estudio de validación multicéntrico español (Vázquez-Barquero et al., 2006; $N = 1.100$ sujetos) confirma la máxima calidad psicométrica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.94 - 0.96	Excepcional fiabilidad global; los 6 dominios oscilan entre 0.82 y 0.94.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.88 - 0.93	Gran reproducibilidad temporal a 7 días en patología crónica estable.
Concordancia Interjueces	CCI = 0.86 - 0.92	Alta equivalencia diagnóstica entre autoinforme y aplicación por clínico.
Validez de Criterio	$r = 0.74$ (SF-36 / GAF)	Fuerte convergencia con escalas globales de funcionamiento y salud.
Sensibilidad al Cambio	Tamaño efecto $d = 0.82$	Capacidad documentada para registrar mejoría tras intervenciones de rehabilitación.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO PORCENTUAL ESTANDARIZADO

- **Opciones de Respuesta:** 1 = Ninguna dificultad (0 pts de disfunción); 2 = Leve (1 pt); 3 = Moderada (2 pts); 4 = Severa (3 pts); 5 = Extrema o no puede hacerlo (4 pts).
- **Puntuación Simple Directa:** Suma lineal de las respuestas recodificadas (0 a 4) en los 36 o 12 ítems (rango directo 0 a 144 en forma 36).
- **Puntuación Estandarizada Compleja (Métrica 0% a 100% CIF de la OMS):** La métrica oficial de la OMS transforma el resultado a una escala de porcentaje donde 0% representa ausencia de discapacidad y 100% discapacidad total:

$$\text{Puntuación Porcentual WHODAS 2.0} = \left(\frac{\text{Suma de Puntuaciones Directas Recodificadas}}{\text{Máxima Puntuación Posible}} \right) \times 100$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación porcentual, **mayor nivel de discapacidad** y mayor restricción en la participación social.

6. BAREMOS NORMATIVOS DE LA OMS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CIF

Estratificación CIF	Métrica %	Percentil OMS	Nivel de Discapacidad y Repercusión Funcional
Sin Discapacidad	0% a 4%	$P_1 - P_{50}$	Autonomía plena; funcionamiento independiente en todas las áreas.
Discapacidad Leve	5% a 24%	$P_{51} - P_{84}$	Dificultades leves en movilidad o concentración; roles mantenidos.
Discapacidad Moderada	25% a 49%	$P_{85} - P_{94}$	Punto de corte de impacto clínico; absentismo, reducción de ocio y apoyo familiar.
Discapacidad Severa	50% a 95%	$P_{95} - P_{99}$	Incapacidad laboral; dependencia acusada para tareas domésticas o cuidado.
Discapacidad Total	96% a 100%	$> P_{99}$	Colapso funcional absoluto; dependencia continua de terceras personas.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO DISCRIMINANTE OMS (PERCENTIL 85 / WHODAS $\geq 25\%$):

En las directrices de la OMS y los baremos de dependencia de la Seguridad Social, una puntuación global igual o superior al **25%** (Percentil 85) delimita la presencia de **discapacidad clínicamente significativa** tributaria de adaptaciones en el puesto de trabajo, apoyo sociosanitario formal o reconocimiento pericial de incapacidad.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LA DISCAPACIDAD

PROTOCOLO DE GESTIÓN Y REHABILITACIÓN CIF CON WHODAS 2.0:

- **Paso 1 (Línea Base en Salud Mental o Medicina Física):** Administrar forma 36 ítems para desglosar el perfil específico por dominios.
- **Paso 2 (Estratificación de Áreas Críticas):**
 - *Comprensión y Comunicación* > 40%: Indicar valoración neuropsicológica y terapia ocupacional cognitiva.
 - *Actividades de la Vida Diaria (Trabajo)* > 50%: Solicitar adaptación ergonómica o baja laboral temporal estructurada.
 - *Participación Social* > 40%: Evaluar barreras comunitarias y estigma; vincular a trabajador social de zona.
- **Paso 3 (Monitorización Trimestral):** Una reducción porcentual de $\geq 10\%$ representa una mejoría funcional objetiva.
- **Paso 4 (Dictamen Pericial de Incapacidad):** Integrar el perfil en los informes oficiales de discapacidad y dependencia.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: READAPTACIÓN INTEGRAL TRAS ICTUS Y DEPRESIÓN POST-ICTUS

Identificación: Varón de 56 años, administrativo, con secuelas leves de ictus isquémico derecho hace 8 meses y episodio depresivo mayor post-ictus sobreañadido. En situación de incapacidad temporal, expresa temor angustioso ante la imposibilidad de volver a su empleo.

Perfil Inicial WHODAS 2.0 (36 ítems):

- **Puntuación Global Estandarizada = 42.5% (Discapacidad Moderada a Severa, Percentil 92).**
- **Desglose por Dominios CIF:** Cognición = 38%; Movilidad = 35%; Autocuidado = 12%; Interpersonal = 40%; Actividades Diarias (Trabajo) = 75%; Participación Social = 54%.

Intervención Multidisciplinar: Tratamiento psicofarmacológico con Sertralina 100 mg/día, rehabilitación neuropsicológica de funciones ejecutivas, entrenamiento en marcha con fisioterapia y programa de readaptación ocupacional coordinado con el servicio de prevención de su empresa.

Reevaluación a los 6 Meses: La puntuación porcentual global descendió al **14.2% (Discapacidad Leve / Rango Adaptativo, Percentil 62)**. Cognición = 15%; Actividades Laborales = 20%; Participación = 18%. El paciente logró una reincorporación laboral exitosa a jornada reducida adaptada.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

INFORMANTE CLAVE EN DEMENCIA:

En pacientes con deterioro cognitivo severo o anosognosia (demencia, psicosis activa), utilizar obligatoriamente la versión para familiares o cuidadores.

DIFERENCIAL DISCAPACIDAD VS. ENFERMEDAD:

El WHODAS no diagnostica patologías; evalúa consecuencias funcionales. Dos pacientes con la misma enfermedad pueden tener discapacidades muy dispares.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. World Health Organization. (2010). *Measuring health and disability: Manual for WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0)*. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. World Health Organization.
2. Vázquez-Barquero, J. L., Herrera, S., Vázquez-Bourgon, E., et al. (2006). Spanish version of the WHO Disability Assessment Schedule II (WHO-DAS II). *Medicina Clínica*, 126(7), 241-248.
3. Üstün, T. B., Chatterji, S., Kostanjsek, N., et al. (2010). Developing the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0. *Bulletin of the World Health Organization*, 88(11), 815-823.
4. Garin, O., Ayuso-Mateos, J. L., Almansa, J., et al. (2010). Validation of the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 in patients with chronic diseases. *Health and Quality of Life Outcomes*, 8, 51.